

Documento de Requisitos del Producto

Plataforma asistencial y de comunicación con familias

VERSIÓN 0.3

2 de septiembre de 2026

Fecha: 2 de septiembre de 2026 Estado: Consolidado funcional para construir y validar el prototipo navegable
Ámbito inicial: Residencias geriátricas; prototipo exclusivamente con datos ficticios
Propietario de producto: Promotor del proyecto / Dirección clínica
Fuentes funcionales: PRD v0.2; AGENTS.md v1.1; wireframes vigentes de Auxiliar, Enfermería, Medicina, Portal Familiar, Administración y Dirección/Coordinación Clínica
Documento asociado: Matriz de permisos de seis perfiles v0.1

Decisión central de la v0.3: se consolidan los seis perfiles. El centro puede activar o desactivar el servicio de citas y, si lo activa, debe elegir una única modalidad operativa: Reserva directa o Solicitud previa. El Portal Familiar adapta su recorrido a la modalidad vigente.

Límite de uso: este documento no autoriza el tratamiento de datos reales, no sustituye una EIPD, una validación jurídica, una auditoría de seguridad ni los protocolos asistenciales del centro.

Control del documento

Versión	Fecha	Cambio principal	Estado
0.1	08/08/2026	Alcance funcional inicial.	Revisión
0.1-r1	09/08/2026	Ficha, basal y registro cotidiano simplificado.	Revisión
0.1-r2	10/08/2026	Auxiliar: diez áreas, opciones rápidas y circuito prioritario.	Revisión
0.2	24/08/2026	Consolidación de Auxiliar, Enfermería y Medicina.	Consolidado funcional
0.3	02/09/2026	Integración de los seis perfiles, citas configurables, Administración separada de Dirección, multirol, indicadores y permisos consolidados.	Consolidado funcional vigente

Jerarquía documental

1. Decisión explícita del propietario de producto documentada con fecha posterior.
2. PRD v0.3 para alcance, invariantes, entidades y comportamiento global.
3. Matriz de permisos vigente para autorización de acciones y recursos.
4. Wireframe vigente del perfil para detalle de pantalla e interacción.
5. AGENTS.md v1.2 para la forma de trabajar sobre el repositorio.
6. Implementación existente como evidencia del estado técnico, nunca como fuente para inventar requisitos.

Una contradicción debe hacerse visible y resolverse documentalmente. No se corregirá en silencio ni se ampliarán permisos por inferencia.

1. Resumen ejecutivo

La plataforma permite que los profesionales de una residencia registren de forma breve y trazable el estado cotidiano de cada residente, documenten cambios, mantengan continuidad entre turnos, realicen valoración profesional y transformen únicamente la información aprobada en publicaciones comprensibles para familiares autorizados.

La v0.3 incorpora seis perfiles funcionales:

- Auxiliar: observación y registro cotidiano; aviso directo ante situaciones prioritarias.
- Enfermería: valoración, seguimiento, continuidad, escalado, indicaciones ejecutables, derivación, cierre y comunicación familiar cuando resuelve.
- Medicina: valoración médica, conducta, indicaciones, seguimiento, derivación, cierre y comunicación familiar cuando es el punto final.
- Portal Familiar: consulta exclusiva de publicaciones aprobadas y gestión estructurada de citas según configuración.
- Administración: estructura, usuarios, roles, asignaciones, turnos, autorizaciones, programación familiar, citas y auditoría administrativa.
- Dirección/Coordinación Clínica: supervisión operativa, calidad de proceso e indicadores; acceso clínico detallado solo con permiso específico, en lectura y auditado.

La plataforma no diagnostica, prescribe, solicita pruebas, recomienda tratamientos, decide prioridades clínicas ni deriva automáticamente. Tampoco sustituye canales urgentes, llamadas, emergencias, historia clínica oficial o protocolos del centro.

1.1 Propuesta de valor

- Centro: continuidad, trazabilidad y configuración adaptable a su organización.
- Profesionales: registros rápidos, responsabilidades claras y bandejas compartidas.
- Familia: información comprensible en un portal privado y posibilidad de coordinar una cita sin chat clínico.
- Dirección: indicadores agregados y supervisión del proceso sin interferir en la actuación asistencial.

1.2 Resultado esperado

Prototipo navegable capaz de representar con datos ficticios el circuito completo:

Alta administrativa -> basal profesional -> registro cotidiano o evento -> revisión de Enfermería -> seguimiento o escalado -> valoración médica e indicaciones -> derivación si procede -> cierre -> texto familiar -> aprobación -> publicación -> consulta familiar; además, configuración organizativa, agenda, auditoría y supervisión.

2. Problema, oportunidad y límites

2.1 Problemas que se pretenden resolver

- Información cotidiana dispersa o poco útil para las familias.
- Interrupciones y llamadas repetitivas dependientes de disponibilidad individual.
- Falta de claridad sobre quién observó, valoró, indicó, ejecutó, corrigió o cerró.
- Pérdida de continuidad en relevos y seguimientos abiertos.
- Exposición indebida de contenido clínico interno a familiares o perfiles administrativos.
- Dificultad para adaptar horarios, unidades, turnos y citas a centros diferentes.
- Falta de indicadores de proceso con denominador, periodo y ámbito explícitos.

2.2 Fuera de alcance de la v0.3

- Sustituir la historia clínica oficial o el software integral del centro.
- Diagnóstico, prescripción, solicitud de pruebas, triaje o recomendaciones automáticas.

- Mensajería libre entre familia y profesionales.
- Contenido sanitario por email, SMS, WhatsApp o enlaces públicos.
- Notificaciones push en el piloto.
- App móvil nativa; la primera versión será web adaptable/PWA.
- Modo clínico offline con sincronización posterior.
- Administración de medicación, facturación, nóminas, fichaje o gestión laboral avanzada.
- Videollamada propia; solo puede ofrecerse como modalidad si el centro dispone del medio externo adecuado.
- Rankings nominativos de productividad o evaluaciones automáticas de mala praxis.
- Exportación masiva de historias clínicas individuales.
- Integraciones con historias clínicas externas en la primera versión.
- Flujos específicos de Centro de Día y SAAD antes de validar el modelo inicial en residencias.

3. Objetivos y métricas del piloto

Objetivo	Indicador	Meta inicial
Registro viable	Tiempo mediano para cerrar un día sin cambios	<= 60 s por residente
Continuidad	Cambios ordinarios revisados antes del cierre diario	>= 95 %
Seguridad operativa	Eventos prioritarios de Auxiliar con aviso directo documentado	100 %
Trazabilidad	Actuaciones firmadas con autor, rol y marca temporal	100 %
Relevo	Eventos abiertos visibles tras cambio de turno	100 %
Comunicación	Publicaciones con aprobación profesional previa	100 %
Acceso	Operaciones clínicas y familiares validadas en servidor	100 %
Usabilidad	Tareas críticas completadas sin ayuda	>= 90 %

Las metas son hipótesis de validación del piloto, no estándares clínicos universales ni umbrales automáticos.

4. Principios funcionales invariantes

- Basal como referencia: los cambios se comparan con la situación habitual del residente.
- Autoría fiel: quien observa registra; quien valora, indica, ejecuta, corrige o cierra firma su propia actuación.
- Separación de objetos: observación, valoración, conducta, ejecución, publicación familiar y cita son objetos distintos.
- Responsabilidad de equipo: un evento abierto no pertenece permanentemente a la cuenta que inició la valoración.
- Mínimo privilegio: acceso limitado por centro, unidad, residente, asignación, rol activo, autorización y finalidad.
- Autorización en servidor: ocultar botones no constituye seguridad.
- Inmutabilidad trazable: un registro firmado no se elimina ni sobrescribe silenciosamente.
- Vencimiento no equivale a cierre: un objeto fuera de plazo sigue abierto y visible hasta actuación profesional.
- Automatización no clínica: el sistema puede programar una publicación aprobada o reservar un hueco; no redacta, interpreta ni decide clínicamente.

- Urgencias fuera del portal: ninguna pantalla, cita o publicación sustituye el protocolo urgente ni el contacto directo.
- Privacidad por diseño y por defecto: se minimizan datos, exposición, retención y permisos desde el modelo.

5. Roles y responsabilidades

Perfil	Responsabilidad principal	Límite esencial
Auxiliar	Cierre cotidiano, cambios observados y aviso directo cuando proceda	No diagnostica, valora clínicamente, modifica basal, escala a Medicina ni aprueba publicaciones
Enfermería	Basal según permiso, bandejas, valoración, seguimiento, escalado, derivación, indicaciones, cierre y comunicación	No altera observaciones ajenas ni gestiona autorizaciones familiares
Medicina	Escalados, eventos propios, valoración, conducta, indicaciones, seguimiento, derivación, cierre y comunicación	No automatiza decisiones ni atribuye actos a otros
Familiar	Consulta publicaciones y gestiona citas habilitadas para residentes autorizados	No accede a contenido clínico interno ni elige profesional concreto
Administración	Organización, identidades, ubicaciones, roles, asignaciones, turnos, autorizaciones, citas y auditoría administrativa	No participa en actos clínicos ni accede por defecto al historial clínico
Dirección Clínica	Supervisión de proceso, indicadores e informes agregados	No interviene clínicamente desde este perfil; detalle clínico solo en lectura y con permiso específico

5.1 Cuentas multirol

Una cuenta puede tener uno o varios roles autorizados. El usuario debe seleccionar o cambiar explícitamente el perfil activo. Toda actuación conserva usuario, perfil activo, ámbito y fecha/hora. Un cargo organizativo o una posición en el organigrama no concede permisos por sí mismo.

6. Alcance modular

Módulo	Funciones incluidas en v0.3
Acceso	Cuentas individuales, sesión, recuperación, bloqueo y segundo factor según política
Organización	Centros, edificios y plantas opcionales, unidades, habitaciones y plazas/camas
Identidades	Usuarios multirol, cargos separados, asignaciones y estados de cuenta
Residentes	Identidad, ubicación, basal vigente/versionado, Barthel, CFS y cognición documentada
Registro cotidiano	Sin cambios, no valorable y cambio observado
Eventos	Ordinarios/prioritarios, bandejas, valoración, seguimiento, continuidad y cierre
Medicina	Escalados, conducta, indicaciones, seguimiento médico y continuidad
Derivación	Módulo común, vista previa, firma y PDF vinculado al evento
Publicaciones	Texto separado, aprobación humana, programación, corrección y retirada excepcional
Portal Familiar	Publicaciones publicadas, autorizaciones activas y citas según modalidad del centro
Administración	Familias, autorizaciones, contacto urgente, publicaciones, turnos, citas y auditoría
Dirección Clínica	Supervisión operativa, detalle clínico condicionado, indicadores e informes agregados

7. Modelo funcional y estados

7.1 Entidades principales

Entidad	Finalidad	Regla clave
Centro / estructura / unidad	Aislamiento y organización	Toda operación queda ligada a un ámbito autorizado
Usuario / rol / perfil activo	Identidad y capacidad	Cuenta individual; multirol con cambio explícito
Asignación / turno	Ámbito operativo	La planificación no sustituye autorización de seguridad
Residente	Sujeto de atención	Identificador no secuencial y no expuesto en URL
Estado basal / versión	Referencia habitual	Solo uno vigente; históricos vinculados a eventos
Registro cotidiano	Resultado breve	Sin cambios, no valorable o cambio enviado
Evento	Cambio o hecho relevante	Puede originarlo Auxiliar, Enfermería o Medicina
Valoración / actuación	Aportación profesional	No modifica observaciones previas
Seguimiento / continuidad	Trabajo pendiente	Equipo responsable, fecha o criterio y autoría individual
Indicación médica	Tarea a Enfermería	Lectura y realización son hitos distintos
Derivación	Documento externo	Módulo común de Enfermería y Medicina
Familiar / autorización	Vínculo y acceso	Solo autorización activa concede Portal Familiar
Publicación familiar	Contenido externo aprobado	Independiente del evento clínico interno
Agenda / franja / cita	Coordinación estructurada	Modo definido por centro; reserva transaccional
Auditoría	Trazabilidad	No editable por usuarios ordinarios

7.2 Estados consolidados

Objeto	Estados
Registro cotidiano	Borrador -> firmado sin cambios / firmado no valorable / cambio enviado
Evento Enfermería	Pendiente -> en revisión -> en seguimiento / escalado a Medicina / protocolo urgente -> cerrado por Enfermería
Evento Medicina	Pendiente médica -> en valoración -> indicaciones / seguimiento / protocolo urgente -> cerrado por Medicina
Vencimiento	Pendiente fuera de plazo; nunca cierre u ocultación automática
Continuidad	Pendiente de recepción por turno entrante / pendiente de continuidad médica
Indicación	Pendiente de lectura -> leída -> realizada / no realizada con incidencia
Basal	Borrador -> firmado y vigente -> histórico
Autorización familiar	Pendiente -> activa -> suspendida / revocada / caducada
Publicación	Borrador -> aprobada -> preparada -> publicada / correctora / retirada excepcional
Reserva directa	Disponible -> confirmada -> finalizada / reprogramada / cancelada
Solicitud previa	Pendiente de gestión -> propuesta del centro -> confirmada / solicitud de cambio / cancelada -> finalizada

8. Requisitos funcionales

8.1 Autenticación, organización y permisos

- AUTH-01 P0. Cuenta individual para cada profesional, administrador, directivo y familiar.
- AUTH-02 P0. Autorización en servidor por centro, unidad, residente, asignación, perfil activo y permiso específico.
- AUTH-03 P0. Sesiones con caducidad, revocación, bloqueo y recuperación segura; errores que no revelen la existencia de cuentas.
- AUTH-04 P0. Segundo factor antes de utilizar datos reales, según política validada.
- AUTH-05 P0. Una cuenta multirol exige selección explícita de perfil; los permisos no se combinan implícitamente entre perfiles.
- ORG-01 P0. Administración gestiona estructura, usuarios, roles definidos, asignaciones y estados de cuenta; todo cambio sensible queda auditado.
- ORG-02 P0. Cargo organizativo, organigrama, turno y permiso de seguridad son conceptos separados.
- ORG-03 P0. La estructura admite centro, edificio y planta opcionales, unidad/sector, habitación y plaza/cama.
- ORG-04 P1. Turnos con fechas múltiples, recurrencias y excepciones; los solapamientos se muestran y el administrador decide.

8.2 Residente y estado basal

- RES-01 P0. Ficha con nombre, fecha de nacimiento/edad, sexo, unidad y ubicación; identidad no expuesta en URL.
- RES-02 P0. Alta administrativa crea identidad y deja el basal pendiente. Enfermería puede tener permiso adicional de alta si el centro lo configura.
- BAS-01 P0. Nueve áreas: movilidad, alimentación, continencia, aseo/higiene, cognición, comunicación, conducta, sueño y ayudas habituales.
- BAS-02 P0. Índice de Barthel y Clinical Frailty Scale; no se incluye Pfeiffer.
- BAS-03 P0. Barthel mediante diez ítems seleccionables y cálculo automático; no solo puntuación total.
- BAS-04 P0. Cognición: sin deterioro conocido/documentado, DCL, demencia o situación no determinada. Etiología y GDS solo si constan, con fuente y fecha.
- BAS-05 P0. Solo el basal vigente aparece por defecto; las versiones previas se archivan y conservan su relación temporal con eventos.
- BAS-06 P0. Reevaluación versionada por alta, revisión programada o cambio funcional consolidado.
- BAS-07 P0. Enfermería y Medicina solo reevaluarán el basal si el centro les concede el permiso correspondiente.
- BAS-08 P0. No se incorporará material protegido de CFS sin autorización/licencia y versión/idioma permitidos.

8.3 Auxiliar: registro cotidiano y eventos

- AUX-01 P0. La pantalla principal muestra residentes asignados y el estado de su cierre cotidiano.
- AUX-02 P0. Acciones mutuamente excluyentes: Sin cambios, No valorable y Registrar cambio.
- AUX-03 P0. Sin cambios se firma y cierra sin tarea para Enfermería.
- AUX-04 P0. No valorable exige motivo y nunca equivale a estabilidad clínica.
- AUX-05 P0. Registrar cambio admite una o varias de diez áreas: alimentación/hidratación; movilidad/funcionalidad; ánimo/conducta; dolor/malestar; heces/diuresis; sueño; lesiones en piel; participación/relación social; incidencias/caídas; estado de conciencia.

- AUX-06 P0. Las opciones rápidas siguen el wireframe; se utiliza Atragantamiento y se admite texto opcional o libre según área.
- AUX-07 P0. Temperatura opcional; fecha/hora del registro automática; no se exige hora exacta de observación.
- AUX-08 P0. Clasificación inicial ordinaria/prioritaria organiza la bandeja y no diagnostica.
- AUX-09 P0. Situaciones prioritarias iniciales: alteración de conciencia/estado general, caída/lesión/traumatismo, fiebre/sospecha de infección, dolor nuevo/intenso, dificultad respiratoria y déficit neurológico nuevo.
- AUX-10 P0. Un evento prioritario recuerda aplicar el protocolo del centro y exige documentar el aviso directo definido para el prototipo.
- AUX-11 P0. Firmar conserva autoría y envía a la bandeja correspondiente de Enfermería.
- AUX-12 P1. El campo Desde cuándo en estado de conciencia y la carga de persona/canal/hora del aviso se validarán en usabilidad sin bloquear el prototipo.

8.4 Enfermería

- ENF-01 P0. Bandejas compartidas por unidad: prioritarios, ordinarios, seguimientos, indicaciones y comunicaciones pendientes.
- ENF-02 P0. Cerrados salen de bandejas y pasan a Historial; abiertos vencidos permanecen visibles.
- ENF-03 P0. Empezar valoración registra profesional y hora, protege concurrencia y no crea propiedad permanente.
- ENF-04 P0. Observación original no editable, basal vigente y línea temporal bajo demanda.
- ENF-05 P0. Valoración con hallazgos, actuaciones, comunicaciones, resultado y constantes opcionales: T, PA, FC, FR, SpO2, aire ambiente/oxigenoterapia, flujo de O2, glucemia y otra con nombre/valor/unidad.
- ENF-06 P0. Decisiones: cerrar, seguimiento, escalar a Medicina o activar/documentar protocolo urgente.
- ENF-07 P0. Seguimientos compartidos con fecha o criterio; cada actuación conserva autoría.
- ENF-08 P0. Transferencia explícita entre turnos; el evento sigue visible aunque la recepción no se confirme.
- ENF-09 P0. Escalado transmite observación, basal, valoración, constantes, actuaciones y motivo, sin decisión automática.
- ENF-10 P0. Indicaciones médicas: lectura y realización/no realización con incidencia son hitos distintos.
- ENF-11 P0. Enfermería puede registrar un evento observado directamente sin alterar el rol de Auxiliar.
- ENF-12 P0. Si Enfermería cierra, decide si existe comunicación y puede aprobar el texto familiar separado.

8.5 Medicina

- MED-01 P0. Inicio con escalados, seguimientos, indicaciones/incidencias, comunicaciones, residentes e historial autorizados.
- MED-02 P0. El escalado muestra motivo, constantes, actuaciones, tiempo y estado, sin resumen diagnóstico automático.
- MED-03 P0. Observación y valoración de Enfermería permanecen no editables; línea temporal bajo demanda.
- MED-04 P0. Valoración médica con hallazgos/exploración, valoración, constantes opcionales y actuaciones.
- MED-05 P0. Conducta: actuaciones, indicaciones a Enfermería y salida mediante cierre, seguimiento o protocolo urgente.
- MED-06 P0. Indicación con texto, fecha prevista o criterio e información adicional, sin selector automático de prioridad.

- MED-07 P0. Si un resultado es necesario para decidir el desenlace, el médico mantiene el evento en seguimiento; el sistema no decide qué resultado es necesario.
- MED-08 P0. Seguimiento vencido no caduca ni desaparece.
- MED-09 P0. Fin de turno: transferencia al equipo entrante o seguimiento para próxima revisión.
- MED-10 P0. Si Medicina cierra, Enfermería no realiza un segundo cierre.
- MED-11 P0. Medicina puede registrar eventos propios sin reenviárselos.
- MED-12 P0. Si Medicina es el punto final, decide y aprueba la comunicación familiar.

8.6 Derivación a Urgencias

- DER-01 P0. Enfermería y Medicina reutilizan un único módulo funcional.
- DER-02 P0. Vista previa obligatoria antes de firma; editar el informe no altera registros de origen.
- DER-03 P0. Contenido: identificación/centro, basal relevante, Barthel/CFS, cognición/comunicación, motivo y observación, valoraciones, constantes, oxigenoterapia, actuaciones, evolución y firmante.
- DER-04 P0. Servicios contactados y horas permanecen en trazabilidad interna, no como bloque del informe externo.
- DER-05 P0. PDF firmado vinculado al evento e Historial; impresión/descarga auditada en entorno real.
- DER-06 P0. Toda derivación genera una Actualización relevante y exige documentar el intento de llamada al contacto familiar designado, sin retrasar la atención.

8.7 Publicaciones y Portal Familiar

- FAM-01 P0. Familiar y autorización son objetos distintos; solo autorización Activa permite acceso.
- FAM-02 P0. La familia consulta exclusivamente publicaciones aprobadas y publicadas para su audiencia.
- FAM-03 P0. No accede a observaciones, valoraciones, constantes, basal, Barthel, CFS, GDS, indicaciones, seguimientos, derivaciones, historial ni línea temporal interna.
- FAM-04 P0. Modalidad ordinaria por residente: diaria, semanal o solo actualizaciones relevantes. El centro configura día/hora.
- FAM-05 P0. La aprobación siempre es humana. Una publicación ordinaria aprobada se hace visible automáticamente al llegar el momento configurado; el sistema no inventa contenido ausente.
- FAM-06 P0. Una actualización relevante puede publicarse tras aprobación y la relevancia la decide el profesional.
- FAM-07 P0. Visibilidad del portal: publicaciones ordinarias 30 días y relevantes 6 meses. Esto no define la conservación jurídica interna.
- FAM-08 P0. Una publicación publicada es inmutable; un error ordinario se corrige con una publicación correctora vinculada.
- FAM-09 P0. Retirada excepcional solo por privacidad, seguridad, audiencia/residente incorrectos o causa equivalente, con permiso, motivo y auditoría; el original permanece internamente.
- FAM-10 P0. Sin email, SMS, WhatsApp ni push en el piloto. Sin chat, comentarios o botón específico de descarga.
- FAM-11 P0. Ausencia de publicaciones no se presenta como Todo bien, estabilidad o ausencia de incidencias.
- FAM-12 P0. El profesional visible es Equipo asistencial del centro.

8.8 Citas familiares configurables

- CIT-01 P0. El centro puede desactivar el servicio o activarlo con una única modalidad vigente: Reserva directa o Solicitud previa.

- CIT-02 P0. El Portal Familiar consulta la configuración en servidor y muestra solo el flujo aplicable. No ofrece ambos flujos a la vez ni permite elegir modalidad de gestión.
- CIT-03 P0. Solo un familiar con autorización Activa para el residente puede iniciar, consultar, modificar o cancelar su cita.
- CIT-04 P0. El familiar elige Equipo médico o Enfermería y una modalidad habilitada por el centro: presencial, telefónica o videoconferencia. Nunca elige un profesional concreto.
- CIT-05 P0. Todas las pantallas muestran que las citas no son un canal urgente.

Reserva directa

- CIT-D01 P0. El familiar ve exclusivamente huecos realmente disponibles para el equipo y modalidad elegidos.
- CIT-D02 P0. Selecciona fecha/hora, revisa y confirma; el resultado es Cita confirmada sin propuesta administrativa previa.
- CIT-D03 P0. La confirmación es transaccional e idempotente. Dos usuarios no pueden reservar el mismo hueco.
- CIT-D04 P0. Si el hueco se ocupa durante la confirmación, no se crea la cita y se ofrecen alternativas disponibles.
- CIT-D05 P0. Reprogramar vuelve a los huecos disponibles; cancelar exige confirmación y deja trazabilidad.

Solicitud previa

- CIT-S01 P0. El familiar envía una solicitud estructurada con equipo, modalidad habilitada, motivo categorizado, comentario breve opcional y disponibilidad aproximada.
- CIT-S02 P0. La solicitud queda Pendiente de gestión. Administración propone fecha/hora y puede asignar internamente un profesional.
- CIT-S03 P0. El familiar puede aceptar, solicitar otro horario o cancelar; no se habilita chat.
- CIT-S04 P0. Solo la aceptación de la propuesta produce Cita confirmada.

Configuración y continuidad

- CIT-C01 P0. Administración configura equipos, modalidades, franjas recurrentes, duración, antelación mínima, horizonte máximo y bloqueos.
- CIT-C02 P0. Cambiar la modalidad del centro afecta a nuevas operaciones y no reescribe silenciosamente solicitudes o citas existentes; estas conservan estado y auditoría hasta resolución.
- CIT-C03 P0. Toda creación, propuesta, confirmación, reprogramación, cancelación y finalización conserva actor y fecha/hora.

8.9 Administración

- ADM-01 P0. Pantalla inicial con asuntos administrativos, sin eventos, constantes, seguimientos ni indicaciones.
- ADM-02 P0. Gestiona identidad y ubicación del residente sin mostrar información clínica.
- ADM-03 P0. Gestiona familiares, cuentas, autorizaciones y contacto urgente designado.
- ADM-04 P0. Crea, activa, suspende y asigna usuarios; puede asignar múltiples roles a una misma cuenta.
- ADM-05 P0. Configura frecuencia y horarios de publicaciones; no redacta ni aprueba contenido.
- ADM-06 P0. Consulta estado administrativo/técnico de publicaciones sin texto completo por defecto.
- ADM-07 P0. Configura y gestiona el servicio de citas conforme a CIT-01 a CIT-C03.
- ADM-08 P0. Puede realizar retirada excepcional solo con permiso específico.

- ADM-09 P0. Auditoría administrativa de usuarios, roles, asignaciones, autorizaciones, frecuencia, contacto urgente, horarios, citas, retiradas y seguridad.
- ADM-10 P0. No accede por defecto al historial clínico ni modifica registros profesionales.

8.10 Dirección/Coordinación Clínica

- DIR-01 P0. Perfil separado de Administración y de los perfiles asistenciales.
- DIR-02 P0. Supervisión operativa de cierres pendientes, eventos abiertos/vencidos, seguimientos, continuidad, indicaciones con incidencia, derivaciones y estado familiar.
- DIR-03 P0. La supervisión operativa puede identificar residente y episodio cuando sea necesario, sin abrir automáticamente notas completas.
- DIR-04 P0. El contenido clínico detallado y la línea temporal requieren permiso específico de supervisión clínica, son solo lectura y cada acceso queda auditado.
- DIR-05 P0. Dirección detecta pendientes, pero no valora, indica, ejecuta, escala, corrige ni cierra desde este perfil.
- DIR-06 P0. Puede consultar derivaciones e informes si tiene permiso clínico; no generarlos ni firmarlos.
- DIR-07 P0. Supervisa estado de publicaciones; no redacta, modifica ni aprueba.
- DIR-08 P0. Indicadores agregados por ámbito y periodo, con denominador cuando corresponda, sin predicción clínica ni juicio automático.
- DIR-09 P0. No rankings nominativos ni tablas de productividad individual en v0.3.
- DIR-10 P0. Informes agregados de actividad; no exportación masiva de historias individuales.

8.11 Historial, correcciones y auditoría

- HIS-01 P0. Eventos cerrados salen de bandejas y permanecen en Historial según permisos.
- HIS-02 P0. Línea temporal completa plegada por defecto y accesible solo con autorización específica.
- COR-01 P0. Corrección ordinaria: 6 horas por defecto, configurable por centro y limitada al autor.
- COR-02 P0. Fuera de ventana se añade rectificación trazable; original, motivo, autor y fecha permanecen.
- AUD-01 P0. Accesos clínicos detallados de Dirección, retiradas, autorizaciones, cambios de permisos y acciones sensibles quedan auditados.
- AUD-02 P0. La auditoría no se usa como ranking de trabajadores ni expone texto clínico a perfiles no autorizados.

9. Reglas de validación y concurrencia

- Sin cambios, No valorable y Registrar cambio son mutuamente excluyentes.
- No valorable exige motivo; Registrar cambio exige al menos un área.
- Una valoración profesional nunca modifica la observación original.
- Un seguimiento exige fecha o criterio y equipo responsable.
- Confirmar lectura de una indicación no la marca como realizada.
- Una publicación no se aprueba sin audiencia autorizada.
- Solo una autorización Activa permite consulta familiar.
- Un usuario multirol actúa únicamente con el perfil activo.
- Doble pulsación debe ser idempotente.
- Una reserva directa exige exclusión transaccional del hueco.
- Cambiar URL o identificadores nunca amplía acceso.

- Un fallo técnico nunca se presenta como ausencia de información clínica.

10. Requisitos no funcionales

Área	Requisito v0.3
Disponibilidad	Objetivo y SLA a definir antes de producción
Rendimiento	Pantallas críticas utilizables con red móvil razonable
Escalabilidad	Diseño multi-centro con aislamiento lógico verificable
Compatibilidad	Navegadores modernos; tableta y ordenador prioritarios; móvil adaptable
Accesibilidad	Objetivo WCAG 2.2 AA
Resiliencia	Borradores recuperables y liberación segura de edición
Concurrencia	Idempotencia en firmas, valoraciones, publicaciones y reservas
Observabilidad	Errores, rendimiento y seguridad sin texto clínico completo en logs
Mantenibilidad	Estados explícitos, migraciones versionadas y pruebas reproducibles

11. Privacidad, seguridad y protección de datos

- Prototipo exclusivamente con datos ficticios. No se incorporarán nombres, contactos, documentos, capturas o historias reales.
- Antes de datos reales: definir responsable y encargado, finalidades y bases jurídicas; realizar análisis de riesgos y, previsiblemente, EIPD; formalizar contratos; política de conservación; derechos; gestión de brechas; control de proveedores y transferencias.
- Minimización y separación entre contenido asistencial, familiar, administrativo y de supervisión.
- Cifrado en tránsito y reposo, gestión segura de secretos, copias, recuperación y registros de auditoría antes de producción.
- Revocaciones de autorización o cuenta surten efecto en nuevas peticiones aunque exista sesión abierta.
- Sin publicidad, píxeles de marketing, grabaciones de sesión ni analítica invasiva en Portal Familiar.
- Logs técnicos sin contraseñas, tokens, secretos ni texto clínico completo.
- La arquitectura técnica actual del prototipo no se considera validada para producción sanitaria por este PRD.

12. Criterios de aceptación transversales

- Los seis perfiles respetan la matriz de permisos v0.1 y su ámbito.
- Administración y Dirección Clínica aparecen como perfiles separados.
- Una cuenta con varios roles exige cambio explícito de perfil.
- Los tres perfiles asistenciales pueden registrar un evento observado dentro de su ámbito, conservando su rol real.
- Eventos vencidos permanecen abiertos y visibles.
- Lectura y ejecución de indicaciones son estados distintos.
- Enfermería y Medicina reutilizan el módulo de derivación.
- Familiar solo ve publicaciones aprobadas y publicadas.
- Administración no ve contenido clínico por defecto; Dirección solo lo ve con permiso clínico de lectura auditada.
- El centro puede activar/desactivar citas y elegir Reserva directa o Solicitud previa.

- Portal Familiar muestra únicamente el flujo configurado.
- Reserva directa impide doble ocupación del hueco.
- Solicitud previa exige propuesta y aceptación antes de confirmar.
- Citas no permiten seleccionar profesional concreto ni crear chat clínico.
- Retirada excepcional exige permiso, causa y trazabilidad.
- Pruebas negativas confirman que manipular URL, rol o identificador no concede acceso.

13. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Carga de registro	Baja adopción	Acciones globales, formularios breves y medición de tiempos
Bandejas ignoradas	Pendientes sin valorar	Vencimientos visibles y responsabilidad compartida
Pérdida en relevo	Discontinuidad	Transferencia explícita y visibilidad de equipo
Confusión con urgencias	Retraso asistencial	Avisos claros y circuito directo fuera del portal
Comunicación inadecuada	Ansiedad o brecha	Texto separado y aprobación humana
Acceso familiar incorrecto	Brecha grave	Autorización activa, audiencia y pruebas negativas
Acceso directivo excesivo	Exposición innecesaria	Dos niveles, solo lectura, permiso específico y auditoría
Doble reserva	Conflicto operativo	Transacción, unicidad e idempotencia
Cambio de modo de citas	Estados incoherentes	No reescribir citas existentes; transición auditada
CFS sin licencia	Riesgo legal	No incorporar activo protegido sin autorización
Arquitectura prematura	Riesgo de seguridad y coste	Revisión antes de datos reales

14. Decisiones pendientes y puertas de salida

Decisión	Responsable	Momento
Vocabulario final y campo Desde cuándo	Producto + Auxiliar/Enfermería	Pruebas de usabilidad
Carga de persona/canal/hora en aviso prioritario	Producto + centro + DPO	Tras usabilidad
Roles exactos para reevaluar basal	Centro piloto	Antes de permisos productivos
Licencia y versión de CFS	Producto / asesoría	Antes de incorporar el activo
Política de corrección y conservación	Centro + DPO	Antes de datos reales
Criterios operativos de actualización relevante	Dirección clínica + centro	Antes del piloto real
Configuración real de citas, equipos y tiempos	Centro piloto	Antes del piloto en cada centro

Decisión	Responsable	Momento
Autenticación y segundo factor productivos	Seguridad + DPO	Antes de datos reales
SLA, RPO, RTO, backups e infraestructura	Responsable técnico + centro	Antes de producción

15. Hoja de ruta actualizada

Fase	Resultado	Datos
1. Consolidación	PRD v0.3 + matriz de permisos + AGENTS v1.2	Ninguno
2. Auditoría del repositorio	Gap analysis requisito a requisito	Ficticios
3. Dominio y autorización	Estados, entidades, RBAC/ABAC y tests	Ficticios
4. Bloques verticales	Residente/basal -> Auxiliar -> Enfermería -> Medicina -> Familia -> Administración -> Dirección	Ficticios
5. Integración	Flujos end-to-end, concurrencia, auditoría y accesibilidad	Ficticios
6. Preparación de piloto	EIPD, contratos, seguridad, arquitectura y operación	Sin reales hasta autorización
7. Piloto real	Centro/unidad y usuarios limitados	Reales solo tras puertas de salida

16. Referencias

Fuentes funcionales del proyecto

- PRD Plataforma contacto familias v0.2 consolidado, 24/08/2026.
- Wireframe funcional Auxiliar v0.1.
- Wireframe funcional Enfermería v0.1, 12/08/2026.
- Wireframe funcional Medicina v0.1, 23/08/2026.
- Wireframe funcional Portal Familiar v0.1, 27/08/2026.
- Wireframe funcional Administración v0.1, 29/08/2026.
- Wireframe funcional Dirección/Coordinación Clínica v0.1, 01/09/2026.
- AGENTS.md v1.1, 24/08/2026.

Referencias normativas y técnicas de orientación

- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), incluido el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto:
<https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html>
- Agencia Española de Protección de Datos, evaluación de impacto y gestión del riesgo: <https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/2-tus-obligaciones-como-responsable-del-tratamiento/10-evaluacion-de-impacto>
- AEPD, herramienta Evalúa-Riesgo RGPD v2:
<https://www.aepd.es/guias-y-herramientas/herramientas/evalua-riesgo-rgpd>
- OWASP Application Security Verification Standard 5.0:
<https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Anexo A. Cambios principales de v0.2 a v0.3

- Se integran Portal Familiar, Administración y Dirección/Coordinación Clínica como perfiles cerrados para prototipo.
- Administración queda separada de Dirección Clínica.
- Se formaliza el modelo multirol con cambio explícito de perfil.
- Se incorporan estructura física, organigrama, planificación básica y autorizaciones familiares.
- Se consolidan publicación programada, periodos visibles, corrección y retirada excepcional.
- Se establece la bifurcación configurable de citas: Reserva directa o Solicitud previa.
- Se actualiza el comportamiento del Portal Familiar según esa configuración.
- Se incorporan dos niveles de supervisión de Dirección, acceso clínico solo lectura y auditoría.
- Se formalizan indicadores agregados y se prohíben rankings individuales en v0.3.
- Se vincula el PRD a una matriz de permisos consolidada de seis perfiles.

Advertencia final: este PRD define el producto y sus límites funcionales. No constituye protocolo clínico, historia clínica homologada, EIPD, asesoramiento jurídico, certificación de seguridad ni autorización para tratar datos sanitarios reales.